1.6
VULNERABLE CHILD SYNDROME (VCS)

Sofia Nurkemala, M.Psi., Psikolog

Topik	*Vulnerable Child Syndrome* (VCS)
Definisi	*Vulnerable Child Syndrome* (VCS) menggambarkan anak-anak yang dipersepsikan sebagai seseorang yang beresiko memiliki masalah medis, perilaku, atau perkembangan. Keluarga dengan dinamika dari VCS menggunakan sumber pelayanan kesehatan secara berlebih dengan sering kali berkunjung ke dokter.[1] Pertama kali dikenali pada tahun 1964 oleh Green dan Solnit, terkait anak-anak sehat dengan riwayat penyakit yang mengancam jiwa dengan disertai dugaan orangtuanya bahwa anak akan meninggal lebih cepat karena penyakitnya. Beberapa tahun setelah pemulihan dari penyakitnya, anak-anak tersebut menunjukkan berbagai gejala, yaitu sakit bagian perut, tantrum, kesulitan tidur, sakit kepala, dan masalah sekolah.[1]
Penyebab	Gejala-gejala pada VCS berkaitan dengan masalah relasi orangtua-anak sebagai hasil dari reaksi orangtua terhadap penyakit anaknya terdahulu yang dianggap mengancam jiwa. Green dan Solnit berhipotesa bahwa reaksi orangtua terhadap penyakit akut dan mengancam jiwa yang dialami anak, memiliki efek psikologis yang merugikan dalam jangka panjang baik terhadap anak ataupun orangtua. Faktor resiko untuk VSC yaitu [1,4] : o Riwayat infertilitas, keguguran atau sakit/ komplikasi selama kehamilan dan atau paska lahir. o Berat bayi lahir rendah dan prematur, o Penyakit atau kondisi kesehatan yang mengancam anak sejak kecil; (penyakit kuning saat lahir) o Dirawat saat di usia dini/1 tahun awal kelahiran. o Masalah bayi sering menangis atau masalah dalam makan o Ibu baru melahirkan yang mengalami kecemasan atau depresi o Masalah kesehatan keluarga o Menurunnya dukungan sosial o Kehamilan dan masalah kelahiran, masalah gangguan tidur, masalah medis o Masalah perkembangan atau kesehatan mental anak o Masalah kesehatan mental orangtua. Faktor resiko ibu yang memiliki anak dengan VCS : ibu yang mudah khawatir memiliki dukungan sosial yang rendah, menunjukkan perilaku obsesif kompulsif, cemas dan mengalami gejala somatis. [1]

Dipindai dengan CamScanner

Tanda/Ciri-cirinya	Anak mengalami : 1. sakit bagian perut, tantrum, kesulitan tidur, sakit kepala, masalah sekolah[1]. 2. anak menjadi rendah diri, tidak percaya diri, ketakutan terhadap dunia luar, merasa diri lemah, dan sebagainya. Relasi antar orangtua-anak pun kerap menjadi bermasalah.[5] 3. *Self-esteem* rendah, kesulitan belajar.[6] Orangtua mengalami/melakukan[1] : 1. Kekhawatiran berlebih terkait kondisi kesehatan anaknya 2. Sering mengunjungi layanan kesehatan untuk mengecek kondisi kesehatan anaknya
Tipe/Jenis-jenisnya	Pada tahun 1986, Green menggambarkan varian dari *Vulnerable Child Syndrome*, yaitu[3]: 1. The *"illness-prone child"*: anak yang rentan terhadap penyakit, yang tidak memiliki kelainan mendasar yang menyebabkan banyak penyakit dan cedera sehingga memerlukan perhatian medis. 2. Orangtua yang mengawasi anak dengan waspada untuk mengetahui tanda-tanda awal gangguan medis atau perilaku tertentu yang menimpa kerabatnya 3. Orang tua salah menafsirkan variasi normal pada pemeriksaan fisik, hasil tes skrining positif palsu, atau hasil tes yang tampaknya 'tidak normal' sebagai indikasi adanya masalah serius pada anak. Orang tua dari anak-anak dengan kondisi medis kronis yang memiliki pemahaman yang tidak lengkap tentang penyakit anak mereka, mungkin melebih-lebihkan kerentanan anak mereka yang sebenarnya. Semua varian ini memiliki kesamaan dalam seringnya penggunaan layanan kesehatan.
Asesmen	Pelaksanaan asesmen psikologi terhadap *Vulnerable Child Syndrome*, dapat dilakukan melalui : 1. Wawancara a. Riwayat medis anak b. Riwayat perilaku/mental anak c. Riwayat kondisi ibu (saat melahirkan, kondisi mental) 2. Observasi. Observasi terhadap aspek interpersonal, intrapersonal, dan fungsional, pada anak dan orangtua. 3. Pemberian Skala CVS[2], untuk melihat persepsi orangtua terkait kondisi kerentanan anak. a. *My child gets more colds than other children I know* b. *I often think about calling the doctor about my child.* c. *When there is something going around, my child usually catches it.*

Dipindai dengan CamScanner

	d. *In general, my child seems less healthy than other children.* e. *I often have to keep my child indoors because of health issues.* f. *Sometimes I get concerned that my child does not look as healthy as he/she should.* g. *I get concerned about circles under my child's eyes.* h. *I often check on my child at night to make sure he/she is OK.* *Child Vulnerability Scale* (CVS, Forsyth et al., 1996) terdiri dari 8 item yang dinilai dengan 4-poin skala Likert, mulai dari nilai 1 (derajat Sangat Tidak Setuju) sampai 4 (Sangat Setuju). Setiap item merupakan pernyataan yang merefleksikan penilaian orangtua akan kerentanan anak terkait penyakit yang diderita anak. Total skor di atas 10 mengindikasikan persepsi kerentanan anak.
Dinamika Psikologi	Anak-anak yang tumbuh di rumah dan lingkungan yang terlalu terlindungi bisa menjadi takut terhadap dunia. Mereka mungkin tidak dapat menemukan kepercayaan diri mereka, dan mereka mungkin memiliki harga diri yang rendah karena tidak pernah mencapai apapun sendirian. Anak-anak ini menjadi sangat bergantung pada orangtuanya. Ketika mereka tumbuh, mereka mungkin berkembang secara fisik sesuai target, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh secara normal; baik secara pribadi dan psikologis. Oleh karena itu, anak-anak ini mungkin lebih mengalami kesulitan dalam situasi sosial. Anak-anak yang rentan mempunyai lebih banyak kesulitan di sekolah dan dapat mengembangkan ketidakmampuan belajar. Mereka mungkin tidak bisa tidur nyenyak, dan sepertinya mereka selalu menderita beberapa jenis penyakit. Orang tua mungkin merasa bersalah dalam menetapkan batasan atau dalam menghukum anak mereka karena mereka yakin anak mereka sakit.[1] VCS dianggap suatu dinamika keluarga yang maladaptif dan juga terjadi pada keluarga yang tidak mengalami kejadian signifikan, terutama ketika kebutuhan kesehatan mental orangtua tidak terpenuhi. Resiko persepsi orangtua yang berlebih dapat mengarah pada penggunaan yang berlebih akan pelayanan medis, kemungkinan intervensi yang tidak diperlukan, dan praktek *parenting*, kelekatan orangtua-anak, serta perkembangan anak yang rendah atau terhambat. Beberapa faktor mungkin mempengaruhi keluarga untuk mengembangkan relasi dan persepsi terkait anak yang maladaptif. Infertilitas, keguguran atau munculnya komplikasi kehamilan, serta kelahiran premature dapat mengakibatkan VCS.[7] Kondisi VCS juga bisa tidak menyenangkan anak. Tidak jarang anak dipaksa melakukan pemeriksaan penunjang (misal laboratorium, rontgen, dan lain-lain) atas indikasi kekhawatiran orangtua. Selain memberi trauma fisik dan psikologis, situasi ini juga lambat laun bisa membuat munculnya gangguan

Dipindai dengan CamScanner

	perkembangan. Sering didapatkan anak menjadi rendah diri, tidak percaya diri, ketakutan terhadap dunia luar, merasa diri lemah, dan sebagainya. Relasi antar orangtua-anak pun kerap menjadi bermasalah. [5]
Kesimpulan Problem Psikologi/ Penegakan Diagnosa	Untuk kesimpulan atau seseorang mengalami VCS bisa dilihat dari hasil asesmen yang memenuhi ciri-ciri atau tanda-tanda VCS serta skor CVS di atas 10.
Intervensi Psikologi	Dalam menghadapi seorang dengan *Vulnerable Child Syndrome* [5] : 1. Selalu membina hubungan dengan klien secara baik sehingga ia nyaman menyampaikan semua kekhawatirannya. Ini penting agar klien tidak cenderung defensif dan tidak kooperatif sejak awal. 2. Hindari membesar-besarkan masalah atau menakut-nakuti terjadinya komplikasi berat, namun jelaskan secara wajar dan proporsional. 3. Jangan menyalahkan atau mengkritik berlebihan tentang perawatan kesehatan dan pengobatan sebelumnya. Rasa bersalah akan memperburuk kondisi VCS. 4. Konseling terkait [6] : • Membantu anak mengalami dunia yang ia hadapi dan mengijinkannya untuk mulai melakukan sesuatu sendiri, bahkan jika ia terus mempunyai kebutuhan medis. • Tetap ada saat anak membutuhkan; tidak memberhentikannya dari pembelajaran atau pengeksploran, dan tidak selalu membantu melakukan segala hal untuk anak. • Di saat anak mengalami berbagai pengalaman yang banyak dan berbeda serta menyenangkan, hal tersebut bisa menjadi kenangan bagi anak. Dia akan mengembangkan keterampilan sosial dan kepercayaan diri. • Meskipun mungkin sulit pada awalnya, saat anda melihat anak belajar menangani hal baik dan buruk, hal itu akan menjadi lebih mudah. Dan anda akan merasa lebih baik mengetahui bahwa anak anda tumbuh dan berkembang secara maksimal dengan cara yang paling sehat.
Referensi	1. Chambers, Gitten, Leonard. (2017). *Vulnerable Child Syndrome, Parental Perception of Child Vulnerability, and Emergency Department Usage*. Pediatr Emerg Care. 2011 Nov; 27(11): 1009–1013. doi: 10.1097/PEC.0b013e318235bb4f 2. Forsyth, et al. (1996). *The Child Vulnerability Scale: An Instrument to Measure Parental Perceptions of Child Vulnerability*. Journal of Pediatric Psychology 21(1):89-101 DOI:10.1093/jpepsy/21.1.89 3. Green M. (1986). *Vulnerable child syndrome and its variants*.

Dipindai dengan CamScanner

Pediatr Rev. 1986 Sep;8(3):75-80.
doi: 10.1542/pir.8-3-75. PMID: 3332339.
4. Green M, Solnit AJ. (1964). *Reactions to the threatened loss of a child. , vulnerable child syndrome*.
Pediatrics. 1964;34:58–66. [PubMed] [Google Scholar]
5. Leman, Martinus. (2019). *Vurnerable Child Syndrome.* Tabloid MD
https://www.academia.edu/45197226/Vulnerable_Child_Syndrome
6. Murray D. (2021). https://www.verywellfamily.com/vulnerable-child syndrome-and-premature-babies-4147150
7. *Schmitz. (2019). Vulnerable Child Syndrome.*
Pediatr Rev (2019) 40 (6): 313–315.
https://doi.org/10.1542/pir.2017-0243

Dipindai dengan CamScanner